

## 1. Конікотомія; анафіл шок

### Сценарій.

Ви черговий хірург лікарні. Бригадою швидкої медичної допомоги до приймального відділення доставлена пацієнтка 40 років з діагнозом: “ Анафілактичний шок. набряк язика, гортані”.

**Скарги:** на задуху, неможливість зробити глибокий вдих, зуд та почервоніння шкіри, загальну слабкість, втрату свідомості.

**Анамнез захворювання:** Пів години назад після введення ін'єкцій в шкіру обличчя у косметолога, почали з'являтися вищезазначені скарги, що стало причиною виклику на дім БШМД. Інтубація трахеї безуспішна.

**Анамнез життя:** Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій не було.

Спадковість: необтяжена.

**Об'єктивно:** загальний стан важкий, свідомість сплутана, положення вимушене - ортопное. Шкіра бліда, ціаноз носо-губного трикутника з уртикарною висипкою. набряки обличчя, язика, вух, шиї (набряк «Квінке»). Ріст 167 см, вага 63 кг. Дихання поверхневе, м'язи грудної клітини приймають активну участь в акті дихання. При пальпації грудна клітина безболісна. Підшкірної емфіземи немає. При порівняльній перкусії ясный легеневи́й звук. При аускультатії легень амфоричне, приглушене. ЧДР 34 за хв. Межі відносної серцевої тупості не розширені. Тони серця приглушені ритмічні, патологічних шумів немає. ЧСС=Пс=112 за хв., АТ ліва рука 100/50 мм рт.ст.. Живіт невздутый, приймає участь у акті дихання. При пальпації м'який безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Симптом Щоткіна-Блюмберга негативний. Аускультативно - перистальника є. Ділянка попереку без патології. Нирки не пальпуються. Симптом Пастернацького негативний з обох боків. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

Додатково:

### Клінічний аналіз крові

| Показник                       | Значення | Референтні значення                                                                   |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Гемоглобін г/л                 | 120      | 130-160г/л – для чоловіків<br>120-140г/л - для жінок                                  |
| Еритроцити 10 <sup>12</sup> /л | 4,2      | 4,0-5,0×10 <sup>12</sup> /л – для чоловіків<br>3,9-4,7×10 <sup>12</sup> /л –для жінок |
| Кольоровий показник            | 0,75     | 0,85-1,15                                                                             |
| Тромбоцити 10 <sup>9</sup> /л  | 180      | 180-320×10 <sup>9</sup> /л                                                            |

|                               |      |                                                        |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| Лейкоцити 10 <sup>9</sup> /л  | 13,2 | 4,0-9,0×10 <sup>9</sup> /л                             |
| - лімфоцити%                  | 14   | 19-37%                                                 |
| - еозінофіли %                | 15   | 0,5-5,0%                                               |
| - палочкоядерні нейтрофіли %  | 5    | 0-5,0%                                                 |
| - сегментоядерні нейтрофіли % | 70   | 47,0-72,0%                                             |
| - моноцити %                  | 10   | 3,0 – 11,0 %                                           |
| ШОЕ                           | 12   | 1 – 10 мм/ч – для чоловіків<br>2 – 15 мм/ч – для жінок |

## Пульсоксиметрія

| Показник               | Значення | Референтні значення |
|------------------------|----------|---------------------|
| Сатурація киснем крові | 80%      | Вище 90%            |

### 12. Інструкція для стандартизованого пацієнта (за необхідності, якщо це передбачено умовами роботи на станції).

| №п/п                           | Дії                                                               | Текст                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.Комунікативні навички</b> |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1                            | Привітатися.                                                      | Доброго дня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2                            | Ви даєте свою згоду на проведення клінічного обстеження?          | Так                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Збір скарг та анамнезу</b>  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1                            | Які у Вас скарги?                                                 | На задуху, неможливість зробити глибокий вдих, зуд та почервоніння шкіри, загальну слабкість, втрату свідомості.                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2                            | Коли з'явилися скарги, що з Вами трапилось?                       | Пів години назад після введення ін'єкцій в шкіру обличчя у косметолога, почали з'являтися вищезазначені скарги, що стало причиною виклику на дім БШМД. Інтубація трахеї безуспішна.                                                                                                                                      |
| 2.3                            | Якими захворюваннями перехворіли? Чи є алергія? Чи були операції? | Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій не було. Спадковість: необтяжена.                                                                                                                                                    |
| <b>3.Об'єктивне обстеження</b> |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1                            | Огляд з верифікацією виявлених патологічних змін.                 | Я провожу огляд з верифікацією виявлених патологічних змін.<br>Я візуально відзначаю тяжкий загальний стан пацієнтки, вимушене положення (ортопное), виражений набряк обличчя, шиї, язика. Спостерігається ціаноз носо-губного трикутника та уртикарна висипка. Дихання утруднене, поверхнєве. Ознаки гіпоксії очевидні. |
| 3.2                            | Пальпація з верифікацією виявлених патологічних змін              | Я проводжу пальпацію з верифікацією виявлених патологічних змін.<br>Я обережно палькуюшию та верхнідихальні шляхи. Виявляю набряк м'яких тканин обличчя, вух, язика, що обмежує дихання. При пальпації грудна клітка еластична, безболісна, підшкірної емфіземи немає.                                                   |

|                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3                                               | Перкусія з верифікацією виявлених патологічних змін          | <b>Я</b> проводжу перкусію з верифікацією виявлених патологічних змін .<br><b>Я</b> визначаю ясний легеневий звук при порівняльній перкусії, що не свідчить про наявність рідини або пневмотораксу.                                                                                                                                                                                 |
| 3.4                                               | Аускультация з верифікацією виявлених патологічних змін      | <b>Я</b> проводжу аускультацию з верифікацією виявлених патологічних змін.<br><b>Я</b> вислуховую амфоричне, приглушене дихання з обох боків. Частота дихання — 34/хв. Аускультативна картина вказує на часткову обструкцію дихальних шляхів.                                                                                                                                       |
| <b>4.Діагностика</b>                              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.1                                               | Проаналізувати клінічний аналіз крові                        | <b>Я</b> аналізую клінічний аналіз крові .<br><b>Я</b> виявляю еозинофілію (15%), лейкоцитоз ( $13,2 \times 10^9/\text{л}$ ), знижений рівень лімфоцитів (14%).                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.2                                               | SpO2                                                         | <b>Я</b> аналізую дані пульсоксиметра.<br><b>Я</b> фіксую сатурацію 80%, що свідчить про тяжку гіпоксію. Необхідна негайна оксигенотерапія або інвазивне забезпечення прохідності дихальних шляхів                                                                                                                                                                                  |
| 4.3                                               | Встановити попередній клінічний діагноз                      | Анафілактична реакція. Набряк Квінке з обструкцією гортані. Асфіксія.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>5. Визначення тактики ведення та лікування</b> |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.1                                               | Медикаментозна терапія, фізіотерапія, особливості харчування | <b>Я</b> приймаю рішення про про ведення невідкладної медикаментозної терапії: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Адреналін 0,5 мл 0,1% п/ш або в/м негайно.</li> <li>• Глюкокортикоїди (преднізолон в/м 60 мг – 2мл).</li> <li>• Антигістамінні препарати (димедрол – 2-5 мл).</li> </ul> Киснева терапія. 100% 6-8л мин<br>Інтубація трахеї, за неможливості – конікотомія. |

|                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя</b> |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.1                                                         | Рекомендувати профілактичні заходи               | Я рекомендую пацієнтці уникати косметологічних втручань без попереднього алергологічного обстеження. Пораджу носити алергопаспорт або браслет, що вказує на ризик анафілаксії. Необхідне подальше обстеження у алерголога.                                                                                                                   |
| <b>7.Інше</b>                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.1                                                         | Інформування пацієнта про можливі ризики хвороби | <b>Я</b> інформую пацієнтку про можливі ризики хвороби .<br><b>Я</b> поясню пацієнтці (після стабілізації), що анафілактичний шок — це загрозливий для життя стан, що може повторюватись. Я інформую про ризики повторних реакцій, можливість рецидиву, необхідність уникнення алергену, надання письмових рекомендацій і залучення родичів. |

### Чек-лист до практичної навички «Конікотомія»

| № | Маніпуляція                                                                                                                                                                                                                                     | Форма представлення |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Переконалися у відсутності небезпеки для себе та постраждалого, коректне розташування пацієнт-лікар, позначити свою роль                                                                                                                        | Сказати             |
| 2 | Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій (можливо/неможливо отримати)                                                                                                                                                | Сказати             |
| 3 | Обробити руки хірургічним способом (лікар в рукавичках), надіти стерильний одяг, окуляри                                                                                                                                                        | Виконати            |
| 4 | Пальпація і стабілізація гортані:<br>- встати біля плеча пацієнта<br>- розігнути голову пцієнта<br>- недомінатною рукою пропальпувати гортань<br>- 1 та 3 пальцями руки зафіксувати персневидний хрящ, вказівним пальцем позначив місце розрізу | Виконати            |
| 5 | Розрізати мембрану (утримуючи скальпель в правій руці під кутом 60 градусів до шкіри, зробити горизонтальний розріз мембрани 1,5 см, при цьому гостра частина леза звернена до оператора та глибина розрізу обмежена довжиною леза)             | Виконати            |

|   |                                                                                                                                                                                                                      |          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6 | <p>Утримати просвіт трахеї та зробити каудальну тракцію гортані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- використовуючи скальпель як провідник, однією рукою завеси просвіт трахеї трахеальний гачок</li> </ul> | Виконати |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|